



認識心絞痛

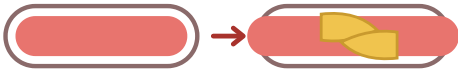
心臟的血管變窄，供血跟不上需求時，胸口就會發出警訊

它是提醒，不是終點——控制得好，可以過正常生活



掃描看電子版

① 什麼是心絞痛？



血流順暢

脂肪斑塊讓管腔變窄

心臟自己也需要血液。冠狀動脈因斑塊變窄時，用力或情緒激動就會供血不足，心肌缺氧而胸悶痛。

② 危險因子有哪些？

可以改變的（治療重點）

抽菸 高血壓 高血脂 糖尿病
肥胖 久坐不動 壓力大 睡眠差

不能改變的

年齡（男 ≥ 45 、女 ≥ 55 ）、男性、
早發性冠心病家族史、慢性腎臟病

③ 有哪些症狀？

典型的樣子

胸口悶、壓、緊，像被大石頭壓住
可傳到左肩、手臂、下巴、上腹
用力時出現、休息幾分鐘會緩解

不典型的樣子（容易被忽略）

只覺得喘、疲倦、冒冷汗、噁心
或像胃痛、牙痛、背痛
女性、糖尿病與長者特別常見

④ 醫師會做什麼檢查？

依症狀與風險高低選擇，不是每一項都要做

基本 心電圖、抽血（心肌酵素、血脂、血糖、腎功能）、心臟超音波
看缺氧 運動心電圖、核子醫學心肌灌注掃描、運動或藥物負荷心臟超音波
看血管 電腦斷層冠狀動脈攝影（非侵入性）；**心導管冠狀動脈攝影是確診與治療的黃金標準**

⑤ 有哪些治療？

藥物是所有人的基礎；是否放支架或開刀，依血管狹窄程度與症狀決定

藥物治療（基礎）

抗血小板藥、statin、
乙型阻斷劑、硝酸甘油等

心導管介入（放支架）

從手腕或鼠蹊部放入導管，
撐開狹窄處並置放支架

冠狀動脈繞道手術

多條或左主幹嚴重阻塞、
合併糖尿病患者常優先考慮

⑥ 我要配合做什麼？

目標值請以醫師為您設定的為準

壞膽固醇 LDL

$< 70 \text{ mg/dL}$

居家血壓

$< 130 / 80 \text{ mmHg}$

糖化血色素

一般 $< 7\%$

身體質量指數

BMI $18.5 \sim 24$

運動 每週 150 分鐘中等強度（快走、騎車）；先問醫師可以做到什麼程度
飲食 少油少鹽少糖、多蔬果全穀與魚；戒菸是所有措施中效益最大的一項
放過支架者的抗血小板藥，未經醫師同意絕對不可自行停用。



⑦ 出現這些情況，立即撥打 119

胸痛持續超過 15~20 分鐘不緩解 | 休息時也發作 | 比平常更痛、更頻繁 | 冒冷汗、喘、快昏倒
舌下含片用法 坐下含 1 錠，5 分鐘未緩解再含 1 錠，最多 3 錠；仍不緩解 → 立即 119。
切勿與壯陽藥（威而鋼等）併用，可能造成嚴重低血壓。

提醒：心絞痛型態改變（更痛、更久、更頻繁，或休息時發作）代表病情可能惡化，請盡快就醫。

資料來源（查核至 2026-09）：

2024 ESC 慢性冠狀動脈疾病指南；2023 AHA/ACC 慢性冠狀動脈疾病指南；

2024 中華民國心臟學會 ASCVD 初級預防指引；2025 台灣血脂管理臨床路徑共識；

2022 台灣高血壓治療指引；台灣糖尿病學會臨床照護指引。本單張供衛教使用，不取代個別診療。

© 2026 林祐騰醫師 編製 本單張僅供臨床衛教使用，未經同意請勿重製、改作或作商業用途。